

03. 기획 의도 (Project Intent & Differentiation Strategy)

03. 기획 의도 (Project Intent & Differentiation Strategy)

문서 정보

버전: v1.0 | 작성일: 2026-05-03 | 상태: 초안 | 작성자: 경북대학교 AI/빅데이터 전문가 양성 과정 — TBD팀

한 줄 요약

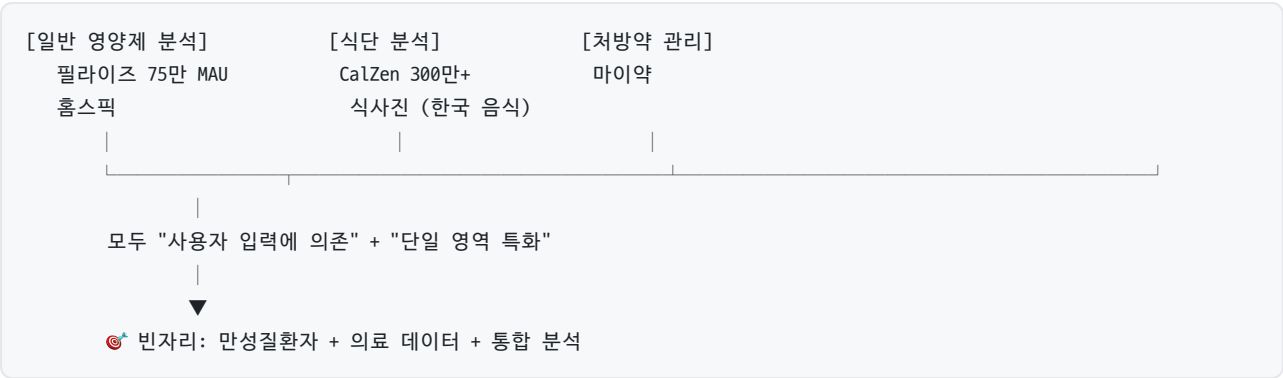
필라이즈 등 선행 주자가 이미 시장을 선점한 상황에서, 레몬헬스케어 가진 의료 데이터 인프라(LDB + 130여 의료기관 네트워크)를 활용해 만성질환자 중심의 차별화된 헬스케어 플랫폼을 구축하는 것이 본 프로젝트의 핵심 기획 의도이다.

목차

- 1. 기획 출발점 — 시장의 빈자리
- 2. 차별화 전략 — 5가지 무기
- 3. 타겟 페르소나
- 4. 핵심 가치 제안 (Value Proposition)
- 5. 성공 시나리오 (3년 로드맵)
- 6. 리스크와 완화 방안
- 7. 전제 조건 (Critical Assumptions)

1. 기획 출발점 — 시장의 빈자리

1.1 기존 서비스 지도



1.2 시장의 빈자리

빈자리	이유
만성질환자 중심 통합 분석	기존 서비스는 일반 사용자용 — 만성질환자는 영양제·운동·식단 권고가 더 까다로움
의료 데이터 연계 가능성	진료기록·처방·검진 데이터까지 통합할 수 있는 곳은 LDB 보유 회사뿐
임상 근거 기반 가중치	v4 만성질환 가중치 같은 정교한 알고리즘은 회사 가이드에만 정의됨
신뢰 가능한 발주처	상급종합병원 80% 점유 + 코스닥 상장 — 의료적 신뢰도 ↑

💡 핵심 인사이트: 필라이즈를 “정면 추격”하는 것이 아니라, “필라이즈가 갈 수 없는 곳”으로 가는 전략이다.

2. 차별화 전략 — 5가지 무기

무기 ①. 의료기관 네트워크 (LDB) — 가장 강력한 차별화

항목	본 프로젝트	필라이즈
사용자 진료 기록 연계	✅ 가능 (LDB)	❌ 불가
처방 정보 자동 반영	✅ 가능 (마이데이터)	❌ 불가
의료기관 협력	✅ 130여 곳	❌ 없음

📌 이것 하나만으로도 만성질환자에게는 차별화가 명확해진다. “내 영양제가 약과 충돌하는지”, “처방 결과가 어떻게 영양 상태를 바꿨는지”는 진료 데이터 없이는 답할 수 없다.

무기 ②. 만성질환 v4 가중 알고리즘 — 임상적 정교함

회사 가이드에 정의된 v4 만성질환 가중치: - 당뇨 +0.10 / 고혈압 +0.10 / 심혈관 +0.15 / 관절 +0.15 / 호흡기 +0.10 (최대 $\times 1.3$) - “동일 활동 대비 만성질환자에게 더 높은 건강 효과 부여”

→ 이 알고리즘은 일반 헬스케어 앱에는 없다. 만성질환자에게 “당신의 7,000보는 일반인의 9,000보와 같은 가치” 라고 말할 수 있는 유일한 앱.

무기 ③. 770만 검증된 사용자 베이스

- 청구의신을 통해 이미 의료 행동 데이터 축적
- 별도의 사용자 확보 비용(CAC) 없이 즉시 마케팅 가능
- 신규 진입자(필라이즈 등)가 따라올 수 없는 출발점

무기 ④. 공식 표준 데이터 활용

- 한국영양학회 KDRIs 2020 기반 30종 영양소
- 보건복지부·식약처 데이터
- 한국·아시아 BMI 분류 (서양 25 미만 정상과 다른 23~ 과체중 분류)
- → “한국인 맞춤” 이라는 명확한 포지셔닝

무기 ⑤. 5종 출력 통합

사진 한 장 → 5가지 답을 한 번에

- | | |
|-------------------|----------|
| ① 부족 영양소 | ② 권장 섭취량 |
| ③ 체중 변화 예측 | ④ 운동 권고 |
| ⑤ 목적별 분석 (눈·간·피로) | |

기존 앱들은 1~2개 영역에 특화되어 있다. 하나의 앱에서 5종을 모두 통합하는 것이 차별화 포인트.

3. 타겟 페르소나

3.1 1차 핵심 페르소나 — B형: “김건강 (52세, 만성질환 관리자)”

👤 김건강 / 52세 / 남성 / 부산 거주
 🏢 중소기업 부장 (사무직 25년차)
 👨‍👩‍👧 가족: 아내, 자녀 2명 (대학생, 고등학생)
 📱 디지털 친화도: 중간 (앱 설치에 신중하게 결정)

건강 상황

- 2년 전 **고혈압** 진단, 작년 **당뇨 전단계** 진단
- 약물: 혈압약 1종 (매일 복용)
- 영양제: **4종 동시 복용** (종합비타민, 오메가3, 칼슘, 마그네슘)
- 체중: 178cm / 84kg → BMI 26.5 (비만 1단계)
- 활동: 평일 6,500보 / 주말 3,000보

페인 포인트 (Pain Points)

분류	구체적 고민
영양제 혼란	“약사 추천 / 인터넷 추천 / 아내 추천이 다 다름. 4종이나 먹는데 진짜 맞는 건가?”
약물 상호작용 우려	“혈압약과 영양제가 충돌하면 어찌지?”
만성질환자 맞춤 정보 부족	“운동 권고도 일반인 기준 → 나에게 맞는지 모름”
합병증 공포	“당뇨로 진행되면 어찌지? 지금 뭘 해야 하나?”
가족 안심	“아내·자녀가 걱정함. 객관적 데이터로 안심시키고 싶음”

Job-to-be-Done (실현하고 싶은 일)

1. 내가 먹는 영양제가 **약과 충돌하지 않는지** 확인하고 싶다
2. 내 건강 상태에 맞는 **만성질환자용 권장량**을 알고 싶다
3. 합병증 예방을 위해 **무엇을 더 하고 덜 해야 하는지** 알고 싶다
4. 가족에게 **객관적 수치**로 보여주고 싶다

성공의 모습 (이 앱을 쓰면)

- 4종 영양제 사진 한 번 찍으면 즉시 분석 + 약과의 상호작용 검토
- “당뇨 진행 위험 ↓” 같은 정량적 피드백
- 의료진과 데이터 공유 가능 (LDB 연계 시)

3.2 2차 확장 페르소나 — A형: “박직장 (38세, 예방 단계 직장인)”

👤 박직장 / 38세 / 남성 / 서울 거주
 💼 IT 회사 팀장 (앉아서 일하는 시간 8시간+)
 👨‍👩‍👧 가족: 아내, 자녀 1명 (5세)
 📱 디지털 친화도: 높음 (앱 설치·구독 익숙)

건강 상황

- 정기 검진에서 콜레스테롤 ↑, 공복혈당 경계 통보
- 영양제: 종합비타민 1종 (간헐적)
- 체중: 175cm / 82kg → BMI 26.8 (비만 1단계 진입)
- 활동: 평일 5,000보 미만 / 주말 가끔 산책

페인 포인트

- “회식 + 야근 + 운동 부족”의 악순환
- 영양제 정보 과잉 — 뭘 먹어야 할지 결정 못함
- 다이어트 시도 → 매번 실패
- “시간이 없다”

Job-to-be-Done

1. 최소 시간 투자로 건강 관리하고 싶다
2. 만성질환으로 진행되기 전에 예방하고 싶다
3. 효율적인 다이어트 방법을 찾고 싶다

성공의 모습

- 1주/1개월/3개월 후 체중 예측으로 동기 부여
- 야근 후 늦은 밤에도 사진 한 장으로 식단 기록
- “이대로 가면 3년 후 당뇨” 같은 경고로 행동 변화

3.3 페르소나 B vs A — 우선순위 차이

항목	B (1차 핵심)	A (2차 확장)
핵심 기능	영양제 분석 + 약물 상호작용 + 만성질환 가중	체중 예측 + 식단 분석 + 운동 권고
UI 우선순위	명확성·안정감·큰 글씨	빠른 입력·시각화·동기부여
차별화 무기	LDB 의료 데이터 연계 (무기 ①)	5종 출력 통합 (무기 ⑤)
마케팅 채널	의료기관·약국 제휴, 가족 추천	직장인 커뮤니티, 헬스 인플루언서

4. 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

4.1 페르소나 B용 (1차)

“만성질환을 가진 분이라면, 일반 영양제 앱은 충분하지 않습니다.
건강의신은 진료 데이터까지 연결해 약·영양제·식사·운동을 함께 봅니다.”

핵심 메시지: - ☒ 약과의 상호작용 검토 - ☒ 만성질환자 맞춤 권장량 (KDRIs + v4 가중) - ☒ 의료진과 데이터 공유 (향후) - ☒ 합병증 예방 시뮬레이션

4.2 페르소나 A용 (2차)

“바쁜 직장인을 위한, 사진 한 장으로 끝나는 건강 관리.
3개월 후 당신의 체중·건강 상태를 미리 보세요.”

핵심 메시지: - ☒ 사진 한 장 → 5가지 분석 (영양제·식단·체중·운동·목적별) - ☒ 1주/1개월/3개월 후 체중 예측 - ☒ 만성질환 진행 위험 사전 경고 - ☒ HealthKit·Health Connect 자동 연동 → 입력 부담 ↓

5. 성공 시나리오 (3년 로드맵)

Year 1 (2026): PoC + 베타

- 학생 팀: Phase 0~4 완료, 발표
- 회사: 만성질환자 100명 클로즈드 베타 (의료기관 협력)
- 핵심 검증: RQ1~RQ4 답변 완료

Year 2 (2027): 정식 출시 + 의료기관 연계 시범

- 건강의신 정식 출시

- 5~10개 의료기관과 LDB 연동 시범 (페르소나 B 진입점)
- KPI: MAU 50만, 만성질환자 비율 30%+
- ISMS-P 인증 추진

Year 3 (2028): 마이데이터 통합 + DTx 진입 검토

- 의료 마이데이터 채널 연동 (보건복지부 사업 연계)
- DTx (디지털치료기기) 인허가 검토 시작
- 글로벌 확장 시범 (일본·동남아)

6. 리스크와 완화 방안

#	리스크	영향도	발생 가능성	완화 방안
R1	페르소나 B 디지털 친화도 ↓	중	높음	UI 단순화, 큰 글씨 모드, 가족 보조 모드, 음성 안내
R2	의료법·약사법 표현 위반	높음	중	면책 고지 표준화, 법무 검수, 의료자문위 검토
R3	필라이즈 등 경쟁자가 만성질환 영역 진입	중	중	LDB 연계로 따라올 수 없는 해자 구축
R4	만성질환자 데이터 부족	중	중	청구의신 사용자 풀에서 만성질환자 표본 확보, 의료기관 협력
R5	OCR·LLM 정확도 미달	높음	낮~중	다중 OCR 엔진 (Google + CLOVA), 폴백 룰
R6	회사 가이드 산출식의 임상적 한계	중	낮음	의료자문위 검증, Hall 동적 모델 등 보완
R7	개인정보 유출 사고	매우 높음	낮음	AES-256 암호화, ISMS-P, 별도 동의 UI
R8	DTx로 오인되어 식약처 규제	중	낮음	표현 가이드 엄격화, 사전 법률 검토

7. 전제 조건 (Critical Assumptions)

본 기획이 성립하기 위한 전제 조건들. 이 중 하나라도 무너지면 기획을 재검토해야 한다.

#	전제	검증 방법
A1	의료자문위 구성이 가능하다	회사가 130여 의료기관 네트워크 보유 → 가능성 매우 높음
A2	사용자가 만성질환 정보를 자발적으로 입력한다	페르소나 B는 이미 약 복용 중 → 동기 충분, UI에서 인센티브 제공
A3	HealthKit/Health Connect가 신뢰할 만한 걸음수를 제공한다	이미 검증된 플랫폼 → 안정적
A4	회사 가이드(v1~v4, 7-step)가 임상적으로 타당하다	Mifflin-St Jeor·KDRIs 모두 표준 → 타당, 단 한국인 보정 필요
A5	OCR + LLM 조합으로 영양제 라벨 정확도 $\geq 85\%$ 달성 가능	업계 표준 (Google Vision 92~98% 보고) → 가능성 높음
A6	학생 팀의 10주 일정이 충분하다	Phase 0~4 마일스톤 도달 가능성 — 진행 중 점검 필요

변경 이력

버전	날짜	변경 사항	작성자
v1.0	2026-05-03	초안 작성. 페르소나 B 1차, A 2차 확장 구조 채택	TBD

관련 문서

- [01. 프로젝트 개요](#)
- [02. 배경 및 문제 정의](#)
- [04. 시장 분석·벤치마킹](#)
- [08. 구현 계획](#)
- [10. 컴플라이언스 체크리스트](#)